

Podłoże *biopsychospołeczne*

Uzależnienie nie wybiera ludzi „słabych” — wybiera ludzi z określoną kombinacją czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych.

CZAS: 25 min czytanie + refleksja Psychoedukacja — bez skali

ŹRÓDŁO: Engel (1977); Volkow i wsp. (2012, NEJM)

JAK UŻYWAĆ

Karta porządkuje wiedzę o **trzech poziomach podatności** na uzależnienie:  **biologiczny** (genetyka, neurochemia, choroby),  **psychologiczny** (osobowość, regulacja emocji, historia traum),  **społeczny** (środowisko, dostępność, relacje). Po przeczytaniu zaznacz w każdej kategorii czynniki, które Cię dotyczą. To nie diagnoza — to **mapa zrozumienia**, dlaczego u Ciebie się to rozwinęło.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Model biopsychospołeczny (Engel 1977) zastąpił monomorficzny model „uzależnienia = słaba wola”. Współczesna neuronauka uzależnienia (Volkow i wsp. 2012, *New England Journal of Medicine*) potwierdza: uzależnienie to **zaburzenie mózgu**, w którym układ nagrody, kontrola wykonawcza i regulacja stresu są zmienione przez powtarzającą się ekspozycję na substancję u *osoby z podatnym układem*. Świadomość trzech poziomów: 1) zmniejsza wstyd („to nie tylko moja wina”), 2) wskazuje precyzyjnie, *gdzie* pracować w terapii (np. trauma → praca z traumą; izolacja → sieć wsparcia).

01 Trzy poziomy — co składa się na podatność



BIOLOGIA

Genetyka — 40-60% ryzyka dziedziczne (badania bliźniąt, Verhulst i wsp. 2015)
Neurochemia — wrodzona niska wrażliwość receptorów dopaminowych D2
Choroby — ADHD, depresja, lęk, bezsenność
Wiek startu — używanie przed 18 r.ż. ↑ ryzyko 4x
Płeć / hormony — szybszy rozwój uzależnienia u kobiet (efekt teleskopowy)



PSYCHOLOGIA

Cechy osobowości — impulsywność, poszukiwanie nowości
Regulacja emocji — używanie jako jedyny sposób na regulację
Trauma — wczesnodziecięca (ACE), PTSD (3x ryzyko)
Schematy — niewystarczalność, opuszczenie, deprivacja
Pierwsze doświadczenie — silnie pozytywne („w końcu czuję się normalnie”)



ŚRODOWISKO

Rodzina pochodzenia — używanie w rodzinie
Rówieśnicy — krąg używających (norma społeczna)
Stres chroniczny — praca, finanse, bieda
Dostępność — bliskość punktów sprzedaży, sieć dilerska
Kultura — alkohol jako element życia społecznego
Samotność — brak więzi

02 Pole „wspólnych obszarów”



Uzależnienie rozwija się **w obszarze przecięcia** trzech poziomów. Sam jeden poziom rzadko wystarcza: osoba z genetyczną predyspozycją, ale dobrym środowiskiem i odporną psychologią — często nie rozwija uzależnienia. Praca terapeutyczna celuje w *poziom, na który można wpłynąć*: psychologię i środowisko. Biologia jest dana, ale jej wpływ daje się modyfikować.

03 Twoja mapa — co u Ciebie

Zaznacz te czynniki, które rozpoznajesz u siebie. To nie diagnostyka — to refleksja. Niektóre będą oczywiste, inne wymagać rozmowy z terapeutą.

BIOLOGIA

— co rozpoznaję u siebie

PSYCHOLOGIA

— co rozpoznaję u siebie

ŚRODOWISKO

— co rozpoznaję u siebie

04 Co z tego wynika dla mojej terapii

NA CO MOGĘ WPŁYNAĆ

— co jest do zmiany (psychologia + środowisko)

NA CO NIE MOGĘ WPŁYNAĆ

— co przyjmuję jako dane (biologia, historia)

PIERWSZY OBSZAR PRACY

— co omówię z terapeutą

Klucz: Volkow i wsp. (2012, NEJM, „Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction”) na podstawie 30 lat badań pokazują, że uzależnienie to *choroba mózgu*, w której zmieniona dopaminergiczna sygnalizacja w prążkowiu i osłabiona kontrola przedczołowa **wyjaśniają zachowanie**, którego pacjent sam nie rozumie („dlaczego znowu, mimo że wiem”). To nie usprawiedliwienie — to *opis mechanizmu*. Mapa biopsychospołeczna pokazuje, że **terapia jest możliwa tylko na poziomach, na które można wpłynąć**. Tam idziemy.